



Progetto **SI.Ter** (**S**istema **I**nformativo **T**erritoriale)

Presentazione alla Cabina di Regia

25 MARZO 2026



- **CONTESTO**
- **OBIETTIVI**
- **ITER PROCEDURALE**
- **LINEE DI INTERVENTO**
- **PROSSIMI PASSI**



- **CONTESTO**
- OBIETTIVI
- ITER PROCEDURALE
- LINEE DI INTERVENTO
- PROSSIMI PASSI



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DM 77, Decreto 23 maggio 2022, n. 77

Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale.

Allegato n° 1, capitolo 16: SISTEMI INFORMATIVI

*Tutte le unità operative territoriali che compongono il Distretto devono essere dotate di **soluzioni digitali** idonee ad assicurare la **produzione nativa dei documenti sanitari in formato digitale**, secondo gli standard adottati a livello nazionale, e la **condivisione dei dati relativi a ciascun paziente tra i diversi professionisti sanitari** coinvolti nell'assistenza: ciò al fine di consentire di realizzare **servizi in rete pienamente integrati**.*



DIGITALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI FONDANTI DEL DM 77 (all. 1):

- Centrale Operativa Territoriale (COT)
- Ospedale di Comunità (OdC)
- Unità Riabilitativa Territoriale (URT)
- Centrale Operativa 116117
- Unità di Continuità Assistenziale
- Assistenza Domiciliare (ADI)
- Rete delle Cure Palliative
- Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie
(in particolare Consultorio e Salute Mentale)
- Casa della Comunità (in particolare per il PUA Punto Unico di Accesso)
- Telemedicina



DIGITALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI FONDANTI DEL DM 77 (all. 1):

- **Centrale Operativa Territoriale (COT)** *(8 su 9)*
- **Ospedale di Comunità (OdC)** *(5 su 11) con altri 6 sw differenti*
- **Unità Riabilitativa Territoriale (URT)** *(2 su 5) con altri 2 sw differenti*
- **Centrale Operativa 116117** *(nuovo ed unico software regionale)*
- **Unità di Continuità Assistenziale** *(assenza o 5 sw differenti)*
- **Assistenza Domiciliare (ADI)** *(4 su 9) con altri 4 sw differenti*
- **Rete delle Cure Palliative** *3 sw differenti*
- **Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie**
(in particolare Consultorio e Salute Mentale) *6/5 sw differenti*
- **Casa della Comunità** **(in particolare per il PUA Punto Unico di Accesso)** *(nuovo/unico software)*
- **Telemedicina** *(collaudo ed avvio nuova piattaforma a febbraio 2026 AULSS2, e AULSS1)*



- CONTESTO
- **OBIETTIVI**
- ITER PROCEDURALE
- LINEE DI INTERVENTO
- PROSSIMI PASSI



1. **per tutte le Aziende ULSS**: unica piattaforma digitale per la gestione clinico-organizzativa dell'assistenza sul territorio, composta dai moduli della stessa ed unica piattaforma software integrata, relativamente alla **COT** (Centrale Operativa Territoriale), **ADI** (Assistenza Domiciliare), **URT** (Unità Riabilitativa Territoriale), **OdC** (Ospedale di Comunità), **HOSPICE** e Cure Palliative e **PUA** (Punto Unico di Accesso)
2. **per le Aziende Ospedaliere e lo IOV**: lo stesso modulo della stessa piattaforma digitale per la gestione clinico-organizzativa in tema di Ospedale di Comunità e Hospice, come le Aziende territoriali
3. **per tutte le Aziende ULSS**: unica piattaforma digitale per la gestione clinico-organizzativa del **CONSULTORIO** (Consultorio, Minori, Età Evolutiva, Neuropsichiatria Infantile, Affidi, ecc...)



4. **per tutte le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere:** lo stesso modulo software della stessa piattaforma digitale per la gestione clinico-organizzativa in tema di **SALUTE MENTALE**
5. **unico portale di accesso al SI.Ter e centralizzazione dell'infrastruttura ICT:** da una situazione disomogenea e non uniforme, migrazione verso un'unica infrastruttura ICT centralizzata in Azienda Zero ottenendo una sola ed unica piattaforma digitale per il Sistema Informativo Territoriale regionale
6. completa integrazione tra il **SI.Ter** (Sistema Informativo Territoriale), il **SIO** (Sistema Informativo Ospedaliero), il **FSE** (Fascicolo Sanitario Elettronico) e la nuova piattaforma della **TELEMEDICINA**



7. **governance centralizzata in Azienda Zero:** per la completa implementazione in tutte le Aziende, la conduzione progettuale ed il supporto operativo alle Aziende e lo sviluppo delle necessarie evoluzioni progettuali
8. **contratti di manutenzione ordinaria:** dal 2026 unico contratto centralizzato in Azienda Zero, con il 2025/2026 anno transitorio a carico delle singole Aziende
9. **reporting, flussi ed indicatori:** unica ed omogenea piattaforma dalla quale elaborare i flussi e gli indicatori del sistema di cruscottistica e di reporting regionale, rispettando i nuovi tracciati e le nuove regole sui flussi informativi, derivanti dal progetto NSIS (nuovo sistema informativo sanitario) nazionale



- CONTESTO
- OBIETTIVI
- **ITER PROCEDURALE**
- LINEE DI INTERVENTO
- PROSSIMI PASSI



- DGR n. 72 del **29 gennaio 2024**: obiettivo in carico ad Azienda Zero “Q.8.3 Analisi e proposta del sistema informativo territoriale”
- Nota di Azienda Zero n. 13820 del **4 giugno 2024**: nomina Gruppo di Lavoro “Sistema Informativo Territoriale”
- Sedute CRITE del **26 maggio** e del **4 giugno 2025**: parere positivo acquisito via protocollo di Azienda Zero n. 18628
- DDG Azienda Zero n. 499 del **14 luglio 2025**: indizione gara mediante Appalto Specifico in adesione all’AQ Consip “Sanità Digitale – Lotto 3”
- DDG Azienda Zero n. 708 del **2 ottobre 2025**: nomina Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte
- DDG Azienda Zero n. 820 del **19 novembre 2025**: aggiudicazione della gara per la realizzazione del sistema “SI.Ter”
- Contratto del **30 gennaio 2026**: contratto stipulato/firmato tra Azienda Zero e Al maviva
- Decreto n. 11922 DG Area Sanità e Sociale del **16 marzo 2026**



- CONTESTO
- OBIETTIVI
- ITER PROCEDURALE
- **LINEE DI INTERVENTO**
- PROSSIMI PASSI



LINEE INTERVENTO

- A. FUNZIONI, PROCESSI, INTEGRAZIONI
- B. FLUSSI NSIS, INDICATORI GESTIONALI
- C. INFRASTRUTTURA ICT
- D. PRIVACY, DPIA
- E. DIFFUSIONE NELLE AZIENDE

ESPERTI/LEADER

- **[COT]:**
Vincenzo Barra (A2),
Simonetta Pellini (A9)
- **[Cure Domiciliari]:**
Marco Artico (A4),
Lucia Dalla Torre (A1)
- **[Strutture Intermedie]:**
Francesco Rossi (A8),
Francesca Tiozzo (A3)
- **[Consultorio]:**
Marta Macchi (A6),
Michela Fasolato (A5)
- **[Salute Mentale]:**
Dario Filippo (A3),
Marilena Agresta (A8)

OBIETTIVO DI RISULTATO

VALIDAZIONE CLINICO-ORGANIZZATIVA DI CIASCUN MODULO DI SI.TER

OGNI ESPERTO/LEADER:

- partecipa agli incontri della **Cabina di Regia**, rappresentando lo stato di avanzamento delle attività, eventuali criticità e proposte evolutive, nonché, in fase di diffusione dei moduli SI.Ter, il loro stato di avanzamento
- assicura la **rappresentazione dei processi caratteristici del proprio ambito clinico-organizzativo** all'interno del modulo SI.Ter di competenza, garantendone l'**integrazione con gli altri moduli**
- garantisce la presenza e la coerenza delle **funzioni specifiche** del proprio ambito all'interno del modulo SI.Ter di competenza
- valida il modulo SI.Ter di competenza quale **"Modulo Unico" regionale**, ai fini della diffusione e implementazione uniforme presso le Aziende Sanitarie del Veneto
- collabora con il responsabile del controllo di gestione per la definizione e il consolidamento degli **indicatori clinici, gestionali, di performance e di monitoraggio e dei relativi strumenti di reportistica** ritenuti rilevanti per il proprio ambito, nonché ai fini dell'integrazione nei moduli SI.Ter e nei flussi NSIS
- **assicura il dialogo con i referenti aziendali**, fornendo chiarimenti e supporto sulle scelte strategiche e operative adottate, al fine di consolidare una versione unica e approvata a livello regionale del modulo SI.Ter di competenza



LINEE INTERVENTO

- A. FUNZIONI, PROCESSI, INTEGRAZIONI
- B. FLUSSI NSIS, INDICATORI GESTIONALI
- C. INFRASTRUTTURA ICT
- D. PRIVACY, DPIA
- E. DIFFUSIONE NELLE AZIENDE

ESPERTO/LEADER

- Stefano Nicola (A0)

OBIETTIVI DI RISULTATO

**OTTENIMENTO FINANZIAMENTO PNRR NSIS
DISPONIBILITÀ FLUSSI E INDICATORI SI.TER**

ESPERTO/LEADER:

- partecipa agli incontri della **Cabina di Regia**, rappresentando lo stato di avanzamento, eventuali criticità e proposte di miglioramento
- si avvale del **supporto dei referenti aziendali** per il controllo di gestione per ciascun **flusso NSIS** (Riabilitazione Territoriale, Consultorio, Ospedale di Comunità, Cure Primarie, Salute Mentale), al fine di garantirne la conformità formale agli obiettivi PNRR
- collabora con gli esperti/leader di ambito per la definizione e il consolidamento degli **indicatori clinici, gestionali, di performance e di monitoraggio e dei relativi strumenti di reportistica** ritenuti rilevanti per ciascun ambito
- **analizza e valida indicatori e strumenti di reportistica proposti dal fornitore**
- **assicura la coerenza** tra sistema di indicatori, flussi NSIS e obblighi di monitoraggio PNRR

**LINEE INTERVENTO**

- A. FUNZIONI, PROCESSI, INTEGRAZIONI
- B. FLUSSI NSIS, INDICATORI GESTIONALI
- C. **INFRASTRUTTURA ICT**
- D. PRIVACY, DPIA
- E. DIFFUSIONE NELLE AZIENDE

OBIETTIVI DI RISULTATO**UTILIZZO PIATTAFORMA CENTRALIZZATA MULTI-TENANT DI SI.TER****ESPERTI/LEADER**

- **Claudio Beltrami** (A0)
- **Andrea Rosin** (A3)

ESPERTI/LEADER:

- garantisce il collaudo tecnico dell'installazione **unica multi-tenant** del sistema SI.Ter
- supervisiona gli interventi sistemistici assicurandone la coerenza con l'architettura infrastrutturale regionale, con il supporto del **responsabile dei sistemi informativi**
- vigila sulla corretta implementazione dell'infrastruttura ICT, in conformità alla normativa vigente in materia di **cybersicurezza** e alla **Direttiva NIS2**, validando la relativa asseverazione
- assicura il **presidio tecnico-evolutivo dell'infrastruttura**, segnalando eventuali criticità
- partecipa agli incontri della **Cabina di Regia**, rappresentando lo stato di avanzamento delle attività e le eventuali esigenze di adeguamento



LINEE INTERVENTO

- A. FUNZIONI, PROCESSI, INTEGRAZIONI
- B. FLUSSI NSIS, INDICATORI GESTIONALI
- C. INFRASTRUTTURA ICT
- D. PRIVACY, DPIA**
- E. DIFFUSIONE NELLE AZIENDE

OBIETTIVI DI RISULTATO

RISPONDENZA AI PRINCIPI E NORME PRIVACY REDAZIONE E VALIDAZIONE DPIA

ESPERTI/LEADER

- Fabio De Luzio (A0)
- Marzia Volpato (A1)

ESPERTI/LEADER:

- garantisce e certifica la progettazione secondo il principio di **privacy by design** e la conformità dell'implementazione al **GDPR** e alla normativa vigente in materia di **protezione dei dati personali**
- coordina la redazione delle **DPIA**, coinvolgendo il fornitore, e con il supporto del responsabile per i sistemi informativi
- partecipa agli incontri della **Cabina di Regia**, rappresentando lo stato di avanzamento e segnalando eventuali proposte migliorative o criticità progettuali

**CONSORZIO ARSENAL**

- Samantha De Biasio

ESPERTO/LEADER

- Andrea Rosin (A3)

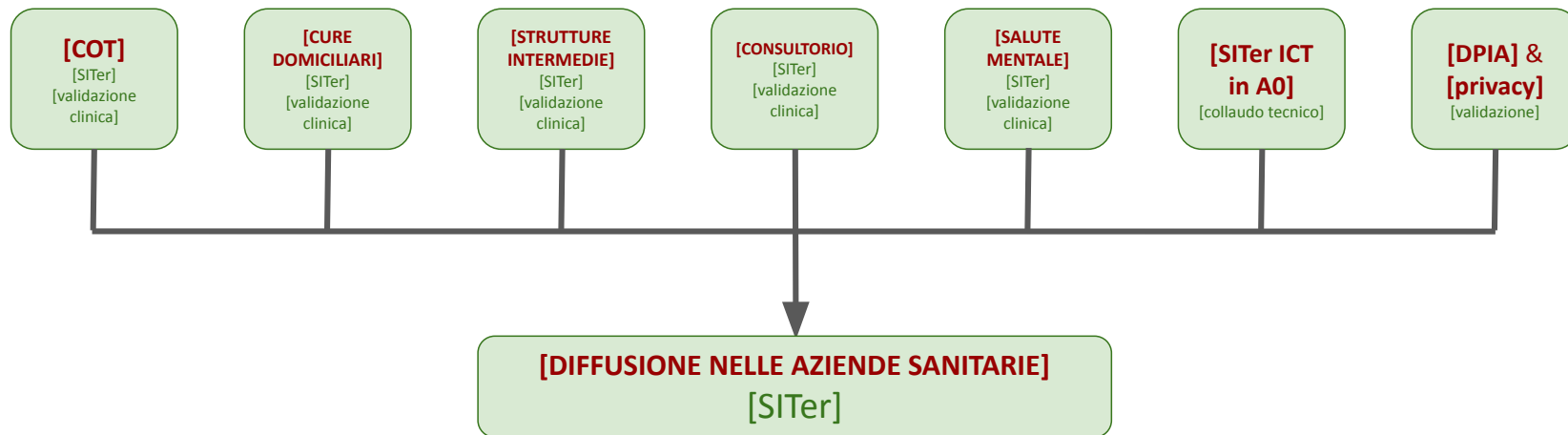
CONSORZIO ARSENAL:

- partecipa agli incontri della **Cabina di Regia**
- garantisce l'attuazione delle **integrazioni tecniche** previste dal capitolato, assicurandone la coerenza con le funzionalità, i processi, i flussi NSIS e il sistema di indicatori definiti nel progetto, infine in collaborazione con il **responsabile dei sistemi informativi**, assicura l'interoperabilità del sistema SI.Ter con l'ecosistema digitale regionale
- in collaborazione con il **responsabile per i sistemi informativi**, garantisce l'applicazione delle integrazioni tecniche in conformità ai decreti relativi al **FSE** e alla normativa sulla protezione dei dati personali



LINEE INTERVENTO

- A. FUNZIONI, PROCESSI, INTEGRAZIONI
- B. FLUSSI NSIS, INDICATORI GESTIONALI
- C. INFRASTRUTTURA ICT
- D. PRIVACY, DPIA
- E. DIFFUSIONE NELLE AZIENDE





LINEE INTERVENTO

- A. FUNZIONI, PROCESSI, INTEGRAZIONI
- B. FLUSSI NSIS, INDICATORI GESTIONALI
- C. INFRASTRUTTURA ICT
- D. PRIVACY, DPIA
- E. DIFFUSIONE NELLE AZIENDE

REFERENTI AZIENDALI

- (A1)
- (A2)
- (A3)
- (A4)
- (A5)
- (A6)
- (A7)
- (A8)
- (A9)
- (AOPD)
- (AOVR)
- (IOV)

OBIETTIVI DI RISULTATO

AVVIO E UTILIZZO COMPLETO SI.TER IN TUTTE LE AZIENDE SANITARIE VENETE

REFERENTI AZIENDALI:

- provvedono alla nomina, ovvero promuovono la nomina da parte del proprio Direttore Generale, del gruppo aziendale di supporto
- coordinano il gruppo aziendale di supporto e si interfacciano con ciascun esperto di ambito per il modulo SI.Ter di riferimento
- rappresentano il punto di contatto e l'interfaccia unica con la propria Azienda Sanitaria
- garantiscono l'esecuzione delle attività di esportazione dei dati dagli applicativi dismessi o in fase di sostituzione
- garantiscono l'attuazione del piano formativo interno
- certificano il collaudo propedeutico all'avvio dei diversi moduli SI.Ter, in quanto scatta il cambio di contratto



LINEE INTERVENTO

- A. FUNZIONI, PROCESSI, INTEGRAZIONI
- B. FLUSSI NSIS, INDICATORI GESTIONALI
- C. INFRASTRUTTURA ICT
- D. PRIVACY, DPIA
- E. DIFFUSIONE NELLE AZIENDE

(OLTRE COLORO CHE SONO GIÀ STATI CITATI)

- Romina Cazzaro (RV)
- Gemma Capano (RV)
- Marco Nardin (RV),
NUE 116117
- Rossana Salata (RV)
- Emanuele Barbierato
(A7), PUA

CABINA DI REGIA

INDIRIZZO STRATEGICO, COORDINAMENTO E PRESIDIO COMPLESSIVO DELLA PROGETTUALITÀ SI.TER

CABINA DI REGIA:

- assicura il **raccordo strategico** tra le diverse linee di intervento e i soggetti coinvolti, garantendo una **visione unitaria** del progetto
- definisce e valida gli indirizzi di sviluppo e le principali **scelte evolutive** della progettualità SI.Ter, sulla base delle proposte formulate dal Gruppo di Coordinamento
- verifica lo **stato di avanzamento complessivo** del progetto, con riferimento alle tempistiche, alle interdipendenze progettuali, senza sovrapporsi alle funzioni operative
- rappresenta la sede di **confronto e indirizzo** per la gestione delle criticità di carattere trasversale o sistemico, demandandone l'attuazione ai livelli competenti



LINEE INTERVENTO

- A. FUNZIONI, PROCESSI, INTEGRAZIONI
- B. FLUSSI NSIS, INDICATORI GESTIONALI
- C. INFRASTRUTTURA ICT
- D. PRIVACY, DPIA
- E. DIFFUSIONE NELLE AZIENDE

RUP

- Luca Giobelli (A0)

GRUPPO DI COORDINAMENTO

- Roberto Da Dalt (A2)
- Manuel Zorzi (A0)
- Silvia Rizzato (A0)

SUPPORTO

- Annachiara Pino
(KPMG)

GRUPPO DI COORDINAMENTO

IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL SI.TER

GRUPPO DI COORDINAMENTO:

- partecipa agli incontri della **Cabina di Regia**, assicurando il raccordo tra le dimensioni progettuale, tecnica, amministrativa e di monitoraggio, ai fini del rispetto degli obblighi PNRR e dei connessi adempimenti amministrativi
- presenta agli incontri della Cabina di Regia le progettualità e ne coordina l'**avvio operativo** con i referenti dei singoli ambiti
- raccoglie la **validazione clinica** di ciascun modulo SI.Ter, sottoscritta dai referenti di ambito
- raccoglie la **validazione tecnico-amministrativa** relativa ai quattro flussi NSIS
- definisce le regole inerenti agli aspetti amministrativo-contabili e alle modalità di fatturazione
- valida la documentazione tecnico-amministrativa ai fini della **rendicontazione PNRR** relativa ai flussi NSIS, all'infrastruttura ICT e alle DPIA, nonché quella concernente il trasferimento dei contratti di manutenzione da ogni Azienda Sanitaria ad Azienda Zero
- garantisce l'**esecuzione del contratto** con riferimento agli aspetti inerenti all'infrastruttura ICT e alla diffusione e all'implementazione dei diversi moduli del progetto SI.Ter, mediante approvazione del relativo cronoprogramma
- acquisisce l'**asseverazione del responsabile in materia di protezione dei dati personali** ai sensi del GDPR



- CONTESTO
- OBIETTIVI
- ITER PROCEDURALE
- LINEE DI INTERVENTO
- **PROSSIMI PASSI**



PROSSIMI PASSI

PROSSIMI PASSI / PROSSIME SCADENZE / PROSSIME AZIONI:

- [KPMG] pianifica, entro **marzo**, le varie presentazioni da parte di [ALMAVIVA] di ogni modulo di SI.Ter a ciascun [ESPERTO/LEADER], verbalizzando gli incontri, definendo le varie azioni susseguenti e gestendo tutta la documentazione
- ogni [ESPERTO/LEADER DI AMBITO] definisce e valida il modulo di sua afferenza, entro fine **maggio**
- il [ESPERTO/LEADER CDG] analizza, propone e valida indicatori, flussi sistemi di reportistica per ciascun ambito, entro **maggio**
- il [ESPERTO/LEADER ICT] garantisce la messa a disposizione dell'infrastruttura al fornitore [ALMAVIVA] per l'installazione unica multi-tenant, entro **giugno**, al fine del collaudo tecnico
- [ARSENAL] garantisce l'attuazione delle **integrazioni tecniche**, da parte del fornitore [ALMAVIVA] e l'interoperabilità di SI.Ter con l'ecosistema digitale regionale, entro **luglio**



PROSSIMI PASSI

PROSSIMI PASSI / PROSSIME SCADENZE / PROSSIME AZIONI:

- [ESPERTI/LEADER PRIVACY] garantiscono e certificano la progettazione secondo i principi della privacy, redigendo le DPIA, entro **luglio**
- il fornitore [ALMAVIVA] implementa le necessarie modifiche entro **luglio**, per ottenere il collaudo funzionale
- il Gruppo di Coordinamento elabora piano di diffusione di dettaglio, entro **giugno**
- il Gruppo di Coordinamento elabora una proposta di evoluzione di SI.Ter, rispetto alle tematiche della “residenzialità extraospedaliera” e della “protesica”, entro **luglio**
- la diffusione nelle Aziende Sanitarie avrà inizio a **settembre**



Grazie per l'attenzione